《言语康复与沟通训练》整合式课程开发研究

王曙光

（东莞市康复实验学校　　广东东莞　　523900）

摘　要：基于“医教结合，综合康复”的教育理念和“缺陷补偿，潜能开发的”教育目标，坚持“教育与康复相结合，康复训练与学科教学相整合”两大原则，通过目标整合、内容整合、实施整合、评价整合、资源整合等五大课程整合策略，开发整合式《言语康复与沟通训练》课程。《言语康复与沟通训练》整合式课程的开发，有利于提升言语康复训练课的数量和质量，促进学生语言理解和运用能力的发展，提高言语康复训练的整合性和持续性。

关键词：特殊教育学校；中重度学生；言语康复；整合式课程开发

中图分类号：G760　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2095-0438(2020)01-0139-04

一、课程开发背景

（一）中重度特殊学生言语康复与沟通训练课程缺乏。特殊教育学校的生源结构发生了很大变化，主要以中重度残疾学生为主，他们普遍存在言语和语言障碍。促进学生的语言能力的发展，提高他们的沟通交流能力，一直是特殊教育学校关注的重点，目前特殊教育学校严重缺乏言语康复与沟通训练课程。因此，根据中重度学生的言语与语言发展特点，开发整合式《言语康复与沟通训练》课程，有助于解决特殊教育学校言语康复课程缺乏的难题，给特殊教育学校言语康复课程的教学和学生的言语康复提供可供参考的经验。

（二）特殊教育学校言语康复训练与学科教学相脱离。特殊教育学校的言语康复训练忽视了学科教学的作用，没有将康复训练融入学科教学中。目前，特殊教育学校的言语治疗师配备不足，如果仅仅依靠单纯的言语康复课很难满足学生对言语康复的需求。将康复训练与学科教学相整合，不仅解决了康复治疗师缺乏的问题，还能充分发挥不同学科的优势，让学生在愉悦的氛围中接受言语语言训练。整合式《言语康复与沟通训练》课程的开发以“医教结合，综合康复”的理念为指导，吸收言语治疗与学科教学的优点，使枯燥的言语康复与沟通训练变得鲜活，使学生愿学、乐学，会学。

（三）学校、家庭言语康复训没有做到持续性发展。中重度特殊学生的言语康复训练必须达到一定的量，才能实现预期的康复目标。目前特殊教育学校的言语康复没有充分发挥家庭康复的作用，学生很难得到持续性的言语康复，严重影响了学生言语康复的效果。整合式《言语康复与沟通训练》课程开发的过程中，非常注重家校合作，通过家长学校转

收稿日期：2019-10-18
作者简介：王曙光（1974-），男，四川岳池人，东莞市康复实验学校讲师，研究方向：特殊儿童教育。
基金项目：广东省教育科学规划课题“医教结合视野下生活化主题教学实践研究”（2019YQJK329）阶段性研究成果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

变家长的教育康复观念，借助专业培训和多元化的课程资源提高家长的教育康复能力，形成一支专业型家长队伍给整合式课程的开发与实施提供支持，以保证学生受到持续性的言语康复。

二、《言语康复与沟通训练》整合式课程的开发

（一）目标的整合。课程目标是教育目标的下位概念，是教育目标在课程领域的具体化，受教育目标的制约，具体体现课程开发与教育活动的价值取向。[1]《言语康复与沟通训练》课程基于“缺陷补偿，潜能开发”的全人教育目标，并根据特殊教育学校学生语言发展的特点，将课程开发的目标整合为“能理解，能表达，会沟通”，即通过课程开发补偿学生的言语缺陷，改善他们的语言能力，尽最大可能地满足他们日常生活沟通交流的需要。为了将整合式课程目标落到实处，要求每节课的教学目标都必需包含认知目标、能力目标、情感目标和康复目标等四维目标，并且四个维度的目标不是割裂开的，而是相互融合，共同为实现课程目标而服务。例如，在教学《乌龟和兔子》一节时，第一课时的目标制定为：知识目标——学习唇韵母“u”的发音方法和学习发“u”的延伸音“娃娃、乌鸦”；能力目标——能正确、清晰地发出长、短音“u”，以及“u”的延伸音“娃娃、乌鸦”；情感目标——体验与同伴、老师共同玩游戏的快乐；康复目标——帮助学生掌握唇韵母“u”的发音方法，矫正学生的发音，能模仿教师的口形双唇缩起圆唇发出“u”音以及“u”的延伸音，提升发音的清晰度，为学生的构音打下基础。

（二）内容的整合。教学内容的选择充分贯彻整合性原则，不仅遵循正常儿童言语语言发展的规律，还考虑特殊教育学校学生认知及言语语言发展的特点，充分体现“医教结合，综合康复”的理念。

1.与主题教学相整合，选择教学内容。言语康复与沟通训练课程开发的目的是为了帮助学生更好地适应生活，学会与他人沟通交流。因此，课程内容的选择要关注学生的生活，围绕学生的日常生活和已有的经验，选择生活化的课程内容。课程开发的过程中借鉴主题教学的经验，与生活化主题教学相整合，围绕“我爱我家”“我的社区”和“我的学校”三个与学生生活息息相关的大主题来建构课程内容。每个大主题下面又包含几个小主题，每个小主题都根据构音部位的发展顺序来确定，一个小主题就是一个章节，每个章节里面的内容都以拼音为媒介选择教学内容。例如，“我爱我家”这个大主题就由“家庭成员”“我的家乡”“招待客人”和“快乐周末”等四个小主题组成。“家庭成员”这个小主题主要学习下颌韵母a、e、i的发音技巧，理解并掌握核心词“爸爸”“妈妈”“爷爷”“阿姨”，会用句式“这是……”表达，并学会与家庭成员互动。根据预设目标，“家庭成员”这一章的三节分别为：“爸爸、妈妈和我(a)”“爷爷和奶奶(e)”“叔叔和阿姨(i)”。通过与生活化的主题教学相整合，课程内容来源于生活，有利于学生习得后更好地应用于生活。

2.与学科教学相整合，选择教学内容。特殊教育学校的学生一般都具有以智力障碍为主，认知障碍、语言障碍与运动障碍为辅的两种甚至两种以上的障碍，[2]所以对他们进行语言康复要以“医教结合，综合康复”的理念为指导，将“教育康复”与“医学康复”相结合，“潜能开发”与“缺陷补偿”相结合，“多重干预”与“重点训练”相结合。[3]因此，在选择课程内容时，将言语康复课中言语治疗的内容融入《言语康复与沟通训练》课程中，通过游戏的形式、通俗易懂的语言和清晰明了的图片呈现在每个章节的“准备活动”和“发音练习”部分，帮助学生习得每个拼音的发音技巧和矫正言语障碍的方法。在每个章节的“言语表达”部分，通过“认一认”“指一指”“找一找”“读一读”“唱一唱”“玩一玩”“亲子时光”等环节将生活语文、唱游与律动、言语游戏与绘本阅读等相整合，围绕每个章节的核心词汇和句式建构内容，促进学生言语语言能力更好地发展。这种多学科整合的形式，充分吸收每门学科的优点，以不同的形式对学生反复进行言语语言刺激，使枯燥的言语康复与沟通训练课程变得鲜活，从而提高康复训练的效果。

（三）实施的整合。课程开发是一项系统工程，基于“医教结合，综合康复”的理念，采用教学团队模式开发课程，能集思广益，充分发挥教学团队各成员的专业优势。教学团队由言语治疗师与生活语文、唱游与律动、绘本教学等学科教师组成。教学团队基于全人教育目标，从不同的学科视角，根据制定课程目标—选择课程内容—实施课程—评价课程效果—开发课程资源等路径研发整合式课程。特别是在课程实施阶段，为了提高课堂教学的效果，借鉴协同教学理念，采用“教学团队”课堂教学模式。即由言语治疗师、生活语文老师、唱游与律动老师和辅助老师共同组成的教学团队，来

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

承担言语康复与沟通训练课程的教学工作：言语治疗师负责组织言语基础、准备活动和发音练习等与言语康复相关部分内容的教学，生活语文老师承担言语表达部分“认一认”“指一指”“找一找”“说一说”“读一读”环节的教学，唱游与律动老师则负责“唱一唱”“玩一玩”环节的教学，言语治疗师、生活语文老师、唱游与律动老师和辅助老师协同教学，共同完成言语康复与沟通训练课程的教学工作。教学团队整合实施课程，能将康复与教育有机结合，充分发挥康复治疗师和学科教师的专长，有效解决整合式课程实施中多学科思维与实践的问题。同时，教学团队还充分发挥家长在整合式课程实施中的作用，通过个别化家庭任务单和活动单以及各种教学视频的指导，提高家长的家庭教育康复能力，对孩子实施有针对性的家庭言语康复，保证了康复训练的持续性、一致性。

（四）评价的整合。评价这一“过程”具有诊断课程、修订课程、比较课程、预测教育需要和确认课程目标达成等功能。[4]整合式课程《言语康复与沟通训练》课程的评价采用多元评价的方式，对课程实施的效果进行评价，以便判断课程目标是否实现，从而更好地调整课程。在评价的主体方面，教师、言语康复治疗师通过《学生语言学习情况评价表》和《S-S法》对学生学习的效果进行评估；家长采用《家庭活动指导单》《家庭阅读指导单》上相应的评价项目对学生在家的学习情况进行评价；同时还充分发挥学生的积极性，让学生对自己上课的表现进行自我评价。在评价的类型方面，坚持定性评价与定量评价相结合，过程性评价与终结性评价相结合。[5]不仅根据学生的实际情况采用量表、评价单对学生的学习效果进行评价，还就学生学习的效果对家长实施访谈，综合量的评价与质的评价的结果，更利于科学地评价学生学习的效果。同时每节课会对学生的学习情况进行评价，每周、每月会综合评价学生课堂表现的情况，教学团队根据评价的结果对课堂教学的内容进行适当的调整。教师和言语治疗师还会以图片、视频、文字的形式收集整理学生上课以及参加综合实践活动的表现等过程性资料，以便结合量表和访谈的结果，对学生学习的效果进行更加全面的评价。为了便于多角度、全面地比较分析学生学习的效果，教学团队采用多种方式呈现评价的效果，如案例报告、成长档案袋、评语、统计图等。

（五）资源的整合。整合式课程开发的过程中注重多元化教学资源的开发与整合利用。教学团队将主题教学与言语康复相整合，选择生活化的教学主题，从家庭出发，经由学校，再到社区、社会，完整呈现言语发生、发展和应用的过程，编写符合言语语言的发生、运用规律的《言语康复与沟通训练》教材，充分展示整合式课程开发模式，将主题教学、言语康复、学科教学、教学团队等元素整合于教材中。教材在内容体系方面，依循言语训练的内在逻辑，依据由简单到复杂的顺序来安排训练，即由动作到语言、由生理到心理、由肌肉运动到音节和音素、由音节音素到语言，最后由语言到交流；呈现方式方面，采用完整、系统、丰富、贴近生活的图画系统，既有实物照片、图画图形，又有漫画，涵盖吃、穿、用、玩，涉及生活的方方面面，便于提高教学效果；内容编排方面，力求活泼、亲切，适应学生的阅读需求。[6]同时，还注重其他形式的文本资源，如教师用书、评价表和家庭指导单等的开发，便于其他教师、家长更好地利用教材。除了丰富的文本资源，还开发多样化的视频资源，如口肌按摩操、下颌运动操、舌部运动操、口腔按摩操和唇部运动操等，有助于非康复专业毕业的教师更好地开展教学，同时也有助于学生的模仿学习以及家长的家庭指导。与此同时，还开发丰富的图片、字卡等供学生操作的教、学具资源和超市购物、餐厅点餐、公园游玩、搭乘公共交通等一系列社区实践资源。多元化的课程资源，更利于提高学生的言语与沟通能力，帮助他们更好地走进社区，融入社会。

三、《言语康复与沟通训练》整合式课程的特点

（一）提升了言语康复训练课的数量和质量。研究中发现，特殊教育学校由于言语治疗师比较缺乏，个训课覆盖的面较窄，单一的个训形式无法满足学生对言语康复训练的需求。《言语康复与沟通训练》整合式课程开发的过程中，根据学生言语与语言能力发展状况，开发言语康复集体课和小组课，对学生实施有针对性的训练。力求通过集体课，进行普惠性的康复训练，布置康复任务、创新康复方法；通过小组课，把基础相近、训练目标一致的学生组成小组，实施有针对性的康复训练，提升康复效果；通过个训课，对学生进行强化训练，补短板、增实效。并将言语游戏引入言语康复课教学中，提升言语康复课的趣味性和效果。这种将集体课、小组

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

课和个训课相组合的方式开发的整合式言语康复课程，有效地提升了言语康复训练的覆盖面，并且将分层分组训练与个别化康复计划的实施有机结合，提升了言语康复课的数量和质量。

（二）促进了学生语言理解和运用能力的发展。整合式《言语康复与沟通训练》课程开发中，尝试将生活化主题教学的元素引入言语康复训练课程，探讨从言语康复训练和学科教学相融合的角度开发言语康复课程。力图在“医教结合，综合康复”理念的指导下，以汉语拼音为桥梁，结合构音部位发展顺序，选择生活化的主题教学内容，将语音学习与言语矫治相结合，语义学习与学科教学相融合，语用学习与社交沟通训练相融合，开发言语治疗与语言教育活动相结合的言语康复课程。这种以多学科融合的策略开发的言语康复整合式课程，教学的内容来源于生活，又有利于学生在生活中泛化，提升了学生理解和运用语言的能力，对学生社会沟通能力的发展也有很好的促进作用。

（三）提高了言语康复训练的整合性和持续性。整合式《言语康复与沟通训练》课程的开发，坚持以“医教结合，综合康复”的理念为指导，遵循“教育与康复相结合”“康复训练与学科教学相整合”的原则，基于“缺陷补偿，潜能开发”的全人教育目标，将言语康复课程的目标完善为“能理解，能表达，会沟通”。在探索“康复训练与学科教学相整合”的路径时，首先建构特殊教育学校与言语康复相关联的学科群，以及不同学科与言语康复的相关点。然后将言语康复与生活语文、唱游与律动、绘本教学等相整合，构建出多学科融合的整合式《言语康复与沟通训练》课程。并组建由言语治疗师和学科教师构成的“教学研合一”的教学团队，解决在“医教结合”视域下，整合式课程开发过程中跨专业多学科思维与实践的问题；建设一支专业型家长队伍，解决学校、家庭言语康复训练的整合式实施问题，确保学生受到持续性的训练。这种整合式课程的开发策略，有效提高了言语康复训练的整合性，确保学校和家庭言语康复训练的持续性。

参考文献：

[1]熊利平.中重度智障儿童语言康复[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(6):61-67.

[2]白银婷.培智学校低学段语言康复课程开发的研究[D].上海:华东师范大学,2010.

[3]余菲,唐小林,唐京梅,等.音乐训练用于人工耳蜗植入儿童听觉言语康复训练效果分析[J].听力学及言语疾病杂志,2018(2):176-180.

[4]傅欣.校本课程评价工具开发:问题、理念与实践[J].教育发展研究,2014(20):40-45.

[5]中华人民共和国教育部.培智学校义务教育生活语文课程标准[M].北京:人民教育出版社,2016:18.

[6]王曙光.言语康复与沟通训练——我爱我家[M].重庆:西南师范大学出版社,2017:2.

[责任编辑　杨贺]

The Development Research on Integrated Curriculum of Speech Rehabilitation and Communication Training

Wang Shuguang

(Dongguan Rehabilitation Experimental School, Dongguan,Guangdong 523900)

Abstract: Based on the educational concept of "combination of medicine and education and comprehensive rehabilitation" and the educational goal of "defect compensation and potential development", adhered to the two principles of "combination of education and rehabilitation, rehabilitation training and subject teaching integration", through the five curriculum integration strategies including target integration, content integration, implementation integration, evaluation integration and resource integration, we develop an integrated course of speech rehabilitation and communication training. The development of this integrated curriculum, can improve the quantity and quality of speech rehabilitation training courses, promote the development of students' language understanding and application ability, and improve the integration and continuity of speech rehabilitation training.

Key words: special education school; moderate and severe students; speech rehabilitation; integrated curriculum development

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net